

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

TEST DE COPIA Y DE REPRODUCCIÓN DE MEMORIA DE FIGURAS COMPLEJAS DE REY

Eje V: Neurocognición • Praxias Visoconstructivas, Memoria Visual y Planificación (Figura A y Figura B)

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Test de Copia y de Reproducción de Memoria de Figuras Geométricas Complejas de Rey.
Nombre Original	Rey Complex Figure Test and Recognition Trial (RCFT; Rey, 1941; Osterrieth, 1944).
Autores Originales	André Rey (1941; diseño de Figuras A y B); Paul-Alexandre Osterrieth (1944; baremación y 18 unidades).
Adaptaciones Hispanas	NEURONORMA (Peña-Casanova, 2009); Estandarización infantil TEA Ediciones (Buisán, 2003/2024).
Eje Clínico y Constructo	Eje V: Neurocognición. Praxias visoconstructivas, memoria visual episódica y funciones ejecutivas.
Formas del Instrumento	Figura A: Niños ≥ 8 años, adultos y ancianos. Figura B: Niños de 4 a 7-8 años y afasia/daño severo.
Fases de Aplicación	Copia con modelo presente, Recuerdo Inmediato (a los 3 min) y Recuerdo Demorado (a los 30 min).
Técnica de Rotación	Rotación secuencial de 5 a 6 lápices de colores para registrar el orden procesual del dibujo.
Tiempo de Aplicación	Copia: 5-15 min; Recuerdo Inm./Dem.: 3-5 min c/u; Duración total de la sesión: 35-45 minutos.
Régimen de Licencia	Estímulos de Rey en dominio público científico; manuales y baremos comerciales de uso profesional.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL, NEUROANATÓMICA Y NEUROEVOLUTIVA

El TFCR es un paradigma cardinal de la neuropsicología mundial, fundamentado en los postulados de la **Gestalt**:

- Jerarquía Perceptiva y Gestalt:** Evalúa la capacidad del sistema nervioso para aprehender un armazón estructural global ordenador frente al procesamiento fragmentado de detalles locales secundarios.
- Doble Sustrato Hemisférico:** La corteza parieto-occipital derecha gobierna la síntesis global y las relaciones topográficas espaciales; el hemisferio izquierdo comanda el análisis de los detalles secuenciales.
- Aporte Frontoparietal y Temporal Medial:** Las redes frontoparietales planifican, secuencian e inhiben perseveraciones; el hipocampo y la corteza entorrenal consolidan y recuperan la huella de memoria visual.
- Diferenciación Evolutiva (Figura B):** En niños de 4 a 7 años, la percepción de formas precede al ajuste del tamaño y los solapes espaciales (Buisán, 2003; 4 factores: percepción visomotriz, orientación, tamaño y proporción).

3. COMPOSICIÓN ESTRUCTURAL COMPARATIVA (FIGURA A VS. FIGURA B)

Forma Estímulo	Estructura y Elementos	Dimensiones Evaluadas y Cómputo Métrico
Figura A (Adultos y ≥ 8 a)	18 unidades de Osterrieth: armazón rectangular, diagonales, medianas y 14 apéndices.	Puntuación 0 a 36 pts por fase (2 pts c/u por forma y posición). 7 tipos procesuales de construcción de Osterrieth (Tipos I a VII).
Figura B (Niños 4 a 7-8 a)	11 elementos: 4 principales (círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo) y 7 secundarios.	4 dimensiones de Buisán / TEA: (1) Presencia (22 pts), (2) Posición (14 pts), (3) Calidad (22 pts), (4) Proporciones y solapes (16 pts).

EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA, REGLAS DE CORRECCIÓN Y BAREMOS

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Muestra y Propiedad	Coefficiente / Métrica	Evidencia Científica y Rendimiento Clínico
Figura A (NEURONORMA)	CCI = 0.94 - 0.98	Concordancia interjueces casi perfecta en la calificación de las 18 unidades ($N > 700$).
Figura A: Estabilidad	Test-retest $r = 0.82$	Alta reproducibilidad en fase de Copia; el recuerdo es sensible al aprendizaje.
Figura A: Validez Clí.	Sensibilidad = 88%	Excelente discriminación de amnesia hipocampal precoz en Demencia tipo Alzheimer.
Figura B: Fiabilidad TEA	Kendall $W = 0.81 - 1.00$	Consistencia interjueces muy elevada en las 4 dimensiones en 332 niños españoles.
Figura B: Análisis Fact.	72.1% varianza explicada	Estructura de 4 factores: Percepción visomotriz, Orientación, Proporción y Solapes.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA

- **Criterios de Corrección para FIGURA A (Osterrieth, 18 unidades, máx 36 puntos):**
 - 2.0 pts: Unidad correcta en forma y emplazamiento espacial exacto.
 - 1.0 pt: Correcta en forma pero mal situada, O deformada/incompleta pero bien situada.
 - 0.5 pts: Deformada y mal situada, pero claramente reconocible.
 - 0.0 pts: Unidad omitida, irreconocible o no dibujada.
 - *Tipologías de Osterrieth:* Tipo I (Armazón rector; maduro), Tipo II (Detalle englobado en armazón), Tipo III (Contorno general), Tipo IV (Yuxtaposición fragmentada; disfunción frontal), Tipo VI (Reducción a objeto familiar), Tipo VII (Garabato).
- **Criterios de Corrección para FIGURA B (Buisán / TEA Ediciones, 11 elementos):**
 - *Dimensión 1 (Elementos presentes):* 2 pts = Reconocible; 1 pt = Difícil o desplazado; 0 = Ausente (máx 22).
 - *Dimensión 2 (Posición de secundarios):* Correcta (2 pts), desplazada (1 pt), ausente/errónea (0 pts) (máx 14).
 - *Dimensión 3 (Calidad de trazo):* Cierre, ortogonalidad a 90°, paralelismo de líneas y perpendicularidad (máx 22).
 - *Dimensión 4 (Proporción y solapes):* Tamaño con modelo (+/-4 mm), proporción relativa y solapes (máx 16).

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Estratificación	Copia A	R. 30m A	Significación Clínica y Estado Neurocognitivo (Adultos)
Normal / Óptimo	32 a 36	18 a 30	Habilidad visoconstructiva y consolidación mnésica preservadas (Tipo I o II).
Déficit Leve	28 a 31	12 a 17	Leve imprecisión grafomotora o dificultad leve de evocación diferida.
Déficit Moderado	20 a 27	6 a 11	Punto de corte patológico sospecha de apraxia o amnesia hipocampal.
Déficit Severo	< 20	< 6	Deterioro grave desestructuración visuoespacial o colapso amnésico masivo.

BAREMOS CENTILES ESPAÑOLES INFANTILES — FIGURA B (TEA EDICIONES, N=332 NIÑOS):

- **4:1 a 4:6 años:** Copia Pc 50 = 17 pts (Pc 10 = 11 pts) | Memoria Pc 50 = 9 pts (Pc 10 = 2 pts).
 - **4:7 a 4:11 años:** Copia Pc 50 = 18 pts (Pc 10 = 12 pts) | Memoria Pc 50 = 11 pts (Pc 10 = 3 pts).
 - **5:0 a 5:6 años:** Copia Pc 50 = 19 pts (Pc 10 = 14 pts) | Memoria Pc 50 = 16 pts (Pc 10 = 8 pts).
- Criterio evolutivo:** En niños menores de 5 años es normativo omitir solapes; la ausencia de cierre básico o puntuaciones inferiores al Pc 10 señalan retraso madurativo o dispraxia que exige estimulación psicomotriz.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN NEUROPSICOLÓGICA Y DIAGNÓSTICO TOPOGRÁFICO

PROTOCOLO CLÍNICO DE LOCALIZACIÓN LESIONAL Y EVALUACIÓN EVOLUTIVA:

- **Paso 1 (Selección y Técnica):** Administrar Figura B a niños de 4 a 7-8 años o adultos con deterioro severo; Figura A a mayores de 8 años. Aplicar rotación cromática de 6 colores para registrar la secuencia y cronometrar.
- **Paso 2 (Análisis del Patrón Neuropsicológico):**
 - **Patrón Amnésico Hipocampal (Alzheimer inicial):** Copia excelente (≥ 32 pts, Tipo I), con desplome en Recuerdo Demorado (< 8 pts; retención $< 30\%$). Fallo primario en la consolidación de la huella mnésica visual.
 - **Patrón Disejecutivo Frontal:** Copia desorganizada o yuxtapuesta (Tipo IV), omisiones y fallos de proporción, pero recuerdo conservado o mejorado con claves; beneficio de pistas estructuradas.
 - **Patrón Parietal Derecho (Heminegligencia):** Omisión sistemática del hemisferio izquierdo del dibujo (cruz exterior, cuadrado izquierdo, diagonales) con distorsión de las coordenadas espaciales.
 - **Patrón de Inmadurez Infantil (Figura B):** Yuxtaposición de formas sin solapes en < 5 años (evolutivamente normal); si a los 6 años persiste fallo de calidad y cierre ($P_c < 10$), sospechar dispraxia o TDAH.
- **Paso 3 (Derivación e Intervención):** Vincular con neuroimagen (RMN temporal medial) en adultos o valoración psicopedagógica en niños.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: DEMENCIA TIPO ALZHEIMER EN FASE INICIAL

Identificación: Varón de 69 años, perito tasador jubilado, derivado por quejas progresivas de memoria episódica reciente (MMSE = 27/30).

Evaluación con la Figura Compleja de Rey (Figura A):

- **Copia:** Total = **34 / 36 puntos** (rendimiento óptimo, Tipo I de Osterrieth; armazón trazado en primer término en 3 min 10 s; praxias visoespaciales y funciones ejecutivas de planificación rigurosamente intactas).
- **Recuerdo Inmediato (3 min):** Total = **8 / 36 puntos** (desaparición de detalles internos; sólo conserva el rectángulo).
- **Recuerdo Demorado (30 min):** Total = **2 / 36 puntos (Desplome catastrófico)**; sólo dibuja una línea horizontal y una cruz; retención $< 6\%$.

Diagnóstico: La disociación extrema entre copia perfecta y recuerdo nulo evidenció fallo severo de consolidación hipocampal. La RMN cerebral confirmó atrofia hipocampal bilateral (Scheltens 2), corroborando Deterioro Cognitivo Leve amnésico prodromático de EA.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

PROHIBIDO ANUNCIAR LA FASE DE MEMORIA:

No avisar jamás al sujeto sobre la prueba de recuerdo diferido; advertirlo activa repaso mnemotécnico voluntario e invalida el constructo mnésico.

INMADUREZ INFANTIL VS. APRAXIA:

En la Figura B, la dificultad de solape entre 4 y 5 años es neuroevolutivamente normal; no patologizar antes de los 6 años salvo disrupción de forma básica.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Rey, A. (1941). L'examen psychologique dans les cas d'encéphalopathie traumatique. *Archives de Psychologie*, 28(112), 286-340.
2. Osterrieth, P. A. (1944). Le test de copie d'une figure complexe: Contribution à l'étude de la perception et de la mémoire. *Archives de Psychologie*, 30, 206-356.
3. Peña-Casanova, J., et al. (2009). Spanish normative studies in young adults (NEURONORMA project): Norms for the Rey-Osterrieth Complex Figure. *The Clinical Neuropsychologist*, 23(5), 872-888.
4. Buisán i Serradell, C. (2003). *Manual de la Figura de Rey: Baremo infantil de la Figura B*. TEA Ediciones.
5. Meyers, J. E., & Meyers, K. R. (1995). *Rey Complex Figure Test and Recognition Trial: Professional Manual*. PAR Inc.